

KC桌面——外资精译

生物制药 | 北美

ADA大会及KOL会议要点总结

来自LLY、PFE和GPCR的ADA最新数据进一步揭示了糖尿病-肥胖症竞争格局。我们仍然认为，这个1900亿美元的市场将容纳多个参与者，不同的疗法将在不同的患者群体中发挥作用。

LLY（增持）——在ADA大会结束后，其凭借业内最广泛的糖尿病-肥胖症产品组合之一，依然处于极为有利的地位，我们认为这是一项关键的

竞争优势：(1) Zepbound/Mounjaro（替尔泊肽；GLP-GIP）在肥胖症和2型糖尿病领域拥有与诺和诺德司美格鲁肽（GLP）头对头的积极3期临床数据，(2) LLY拥有多个具有新颖作用机制的在研管线药物，例如Retatrutide（GLP-GIP-胰高血糖素；在ADA大会上亮相）和Eloralintide（可注射的选择性胰淀素），以及(3) 一款口服小分子GLP-1药物Foundayo（值得注意的是，这不是像诺和诺德口服Wegovy那样的肽类药物，后者限制了可扩展性）。LLY的首席科学官最近指出（见此处），Retatrutide（Reta）可能成为低BMI肥胖症患者的“主力药物”，因为低剂量3期数据在减重、耐受性和剂量递增时间方面与替尔泊肽相比具有优势。我们预测LLY的肠促胰岛素类药物销售额将从2026年的约600亿美元增长至2035年的约1000亿美元。请参阅我们今年早些时候发布的报告《追踪GLP-1的“解锁”》。

ADA大会的研究人员展示了Reta的TRIUMPH-1/肥胖症和TRANSCEND-T2D-1 3期试验的完整数据。报告者将其描述为开辟了一个新领域，我们认为这些数据为基于肠促胰岛素的疗法设立了新的疗效标准，我们将在下文讨论完整的要点。

LLY预计将在2026年下半年提交Reta用于肥胖症的上市申请（2型糖尿病为2027年上半年），并认为Reta符合CNP V计划设定的标准，但拒绝推测此时是否可以走这条路径。我们预测Reta将于2027年上市，2030年风险调整后的销售额为46亿美元（70%的成功概率）。在ADA大会之外，今年晚些时候还将有更多TRIUMPH数据公布，包括针对伴有2型糖尿病的肥胖/超重患者（含OSA亚组）的TRIUMPH-2，以及针对已确诊心血管疾病的肥胖/超重患者的TRIUMPH-3。此外，根据LLY的ADA幻灯片，我们预计市场关注点将集中在预计于2027年公布的TRIUMPH-5（Reta vs. 替尔泊肽）数据上。

在回应活动中关于Foundayo（口服GLP-1）上市的提问时，该公司表示，他们对上市两个月以来所看到的情况感到兴奋，反馈良好且使用人群正在扩大。他们表示尚未启动所有推广手段。请参阅我们每周的处方追踪器（此处）。

LLY强调了Eloralintide（选择性作用于胰淀素

受体1>3）的持续开发，并回顾了之前的2期数据（见我们关于单药治疗数据的看法，此处），特别指出了3mg剂量，该剂量可实现约12%的减重效果，且耐受性与安慰剂相似，无需剂量滴定。他们表示

MS & CO. LLC

Hailey Horowitz

Connor M Massari

Damien H Kerner

MS INDIA COMPANY PRIVATE LIMITED+

Saket Agarwal

2026 EXTEL

全美研究投票

2026年5月26日至6月12日

[查看我们的分析师 >](#)

主要制药公司

符合预期

MS与报告所覆盖的公司有业务往来，并寻求开展此类业务。因此，投资者应意识到该公司可能存在影响MS客观性的利益冲突。投资者应将MS视为做出投资决策的单一因素。

有关分析师认证及其他重要披露，请参阅本报告末尾的披露部分。

目前有5项3期试验正在进行中，并计划开展更多试验，他们预计这将成为LLY历史上最大的临床开发项目之一。他们对这款药物感到兴奋，并预计将在2026年下半年报告与替尔泊肽（GLP-GIP）联用的2期数据。我们预测Elora将于2028年上市，2035年风险调整后的销售额为57亿美元（60%的成功概率）。

投资者对LLY开发潜在更长作用时间的肠促胰岛素（例如每月给药）计划的兴趣也在增加。在LLY的活动中，管理层指出他们正在研究注射频率（我们假设这将针对其现有药物）、新的超长效药物以及口服双靶点和三靶点激动剂，因为他们不想在这个领域留下任何未探索的角落。

PFE（等权重）：Bero benatide（Bero/PFE'3944/MET-097，可注射GLP-1）的概况看起来具有竞争力，与今年早些时候公布的2期顶线数据一致（见此处）。在ADA大会上，关于Bero的讨论更多集中在耐受性而非疗效上，包括从每周给药过渡到每月给药（见下文）。我们认为完整的2期数据支持Bero进入3期，是一个增量利好，但我们预计这不会在现阶段显著改变该股的整体叙事。我们认为，Bero目前更像是安进Maritide（长效GLP-GIP）的潜在竞争对手，而非LLY产品线的对手。PFE的目标是在2028年推出每周给药的Bero（与我们的模型一致），并指出每月给药的批准将很快跟进。对于Bero，我们预测2030/2035年风险调整后的销售额约为20亿美元/45亿美元（60%的成功概率），约占2035年总收入的9%。

GPCR（增持）：展示了完整的Aleniglipron（口服GLP-1）2期数据，包括关于不良事件分期/剂量中断的新数据，以及ACCG-2671（每日一次口服胰淀素/DACRA）有趣的临床前联合用药数据。请参阅我们内部的要点以及我们近期巴士之旅的评论（此处）。

我们还在会议期间与一位学术内分泌学家会面，回顾/讨论了新数据及其对未来肥胖症和2型糖尿病治疗模式的影响。

更多要点请见下文。



图表 1

诺和诺德由Thibault Bouterin负责。阿斯利康和罗氏由Sarita Kapila负责。

内分泌会议要点总结

我们在ADA大会邀请的学术内分泌学家认为Reta的3期数据（见下文）令人印象深刻，减重幅度是有史以来报告的最佳水平。他指出，医生将如何使用该产品将是一个有趣的问题。在他看来，Reta对HbA1c的降低效果与Mounjaro相似（尽管Reta试验中的安慰剂反应不同），这表明要么存在一个下限，要么胰高血糖素具有反向调节机制。

关于Reta的安全性/耐受性，他指出恶心率并不算高，但他认为呕吐率较高，而较低的胃肠道副作用看起来与其他肠促胰岛素药物相当。他认为尿路感染的不平衡是一个较小的增量风险，并确认减重手术也有此报告，但发病机制尚不清楚。鉴于Reta在3期试验中心律失常事件数量较少（见下文），他对心律失常方面感到放心得多，并且似乎不存在传导缺陷（更多是房性性质）。在他看来，主要不良心血管事件的数量也很少，无需担忧。

在他看来，Reta的最佳应用场景是肥胖症，而非2型糖尿病。他认为Reta可能成为部分肥胖患者（尤其是高BMI患者）的一线疗法，但在2型糖尿病领域不太可能超越Mounjaro（在此领域，Reta将用于尝试过Mounjaro并希望进一步减重的患者）。如果他是一名支付方，他会要求患者在使用Reta之前，先尝试口服GLP-1或Sema/Tirz，因此他预计Reta的使用率不会像Tirz那样高。但在直接面向消费者领域，如果LLY将Reta定价与Zepbound持平，那么除非患者担心潜在的副作用（鉴于目前Reta的数据较少），否则没有理由不将其作为一线用药。

在他看来，PFE的Bero（GLP）在肥胖症疗效上与Zepbound相似，在2型糖尿病的HbA1c降低方面也有一定程度的相似性。他很有兴趣看到PFE提高剂量后Bero能达到何种疗效，并认为如果PFE想在市场上具有竞争力，就需要一个卖点，而每月一次的给药角度可能就是这个卖点。在近期与更多患者交流后，他相信市场会对每月一次的选项产生兴趣/需求，但耐受性必须与现有的每周一次药物相似。在他看来，Bero和AMGN的

Maritide（GLP-GIP）的耐受性特征仍然是一个巨大的问号，他希望看到这两种药物的更多数据。但基于现有的2期数据，他会选择Bero而非

Maritide，因为考虑到抗体与多肽在剂量滴定方面的问题，他对多肽方法更放心，这一观点与对GIP拮抗作用的任何考量无关。在他看来，呕吐是这些药物之间需要比较/监测的最重要副作用。

胰淀素类：鉴于GLP-1

类药物在疗效和安全性方面已产生的数据难以被超越，他不认为这些药物是一线疗法。他将诺和诺德的Amycretin描述为渐进式创新，可能优于Cagri-Sema，但对LLY的Elora作为单药疗法的疗效更为乐观。从更宏观的角度看，他更倾向于将胰淀素作为可与其他药物联合使用的独立疗法，因为他喜欢能够单独调整每种药物剂量的能力。

口服GLP-1：虽然他总体上并不是口服GLP-1药物的大量处方者（这些药物在他的实践中只能满足有限的需求），但他认为，考虑到食物和水的限制，Foundayo的特征优于口服Wegovy。他尚未听到任何关于Foundayo的药物相互作用对患者构成问题的讨论。

礼来

礼来凭借其行业内最广泛的糖尿病-肥胖症产品组合之一，仍然处于极其有利的地位，我们认为这是一个关键的竞争优势：(1) Zepbound/Mounjaro（替尔泊肽；GLP-GIP）在肥胖症和 2

型糖尿病方面拥有与诺和诺德司美格鲁肽（GLP）进行头对头比较的积极 3 期数据，(2)

礼来拥有多种具有新颖作用机制的管线药物，例如 Retatrutide（GLP-GIP-胰高血糖素）和 Eloralintide（可注射的选择性胰淀素），以及 (3) 一种小分子口服 GLP-1 药片

Foundayo（值得注意的是，这不是像诺和诺德口服 Wegovy

那样的多肽，后者限制了可扩展性）。礼来的首席科学官最近指出（此处），Retatrutide 也可能成为低 BMI 肥胖患者的“主力药物”，因为低剂量的 3 期数据在减重、耐受性和剂量递增时间方面与替尔泊肽相比具有优势。我们预测礼来的肠促胰岛素类药物销售额将从 2026 年的约 6000 亿美元增长到 2035 年的约 10000 亿美元。请参阅我们今年早些时候发布的报告《追踪 GLP-1 的“解锁”》。

在 ADA 会议上，研究人员在获得阳性顶线结果后（链接和链接），公布了 Retatrutide（Reta；每周一次注射用 GLP-1/GIP/胰高血糖素三重激动剂）的 TRIUMPH-1 和 TRANSCEND-T2D-1 3 期试验的完整数据。TRIUMPH-1 评估了 Reta 与安慰剂在肥胖或超重且至少有一种体重相关合并症的非糖尿病成人中的效果，而 TRANSCEND-T2D-1 则针对 2 型糖尿病人群。报告者称这开辟了一个新领域，我们认为这些数据为基于肠促胰岛素的疗法设立了新的疗效标准。

Reta 疗效：在 TRIUMPH-1 中，根据疗效估计，Reta 12mg 组在 80 周时体重减轻了 28.3%，而安慰剂组为 2.2%。相比之下，Zepbound 在 SURMOUNT-1 试验中减重约 23%；见图表 15。在基线 BMI ≥ 35 的患者中进行的预设扩展研究中，12mg 组的体重减轻持续至 104 周，达到 30.3%。在 TRANSCEND-T2D-1 中，根据疗效/治疗方案估计，Reta 在 40 周时使 HbA1c 降低高达约 2.0%，体重减轻高达 16.8%/15.3%。相比之下，Mounjaro/替尔泊肽在 SURPASS-1 试验中，根据疗效估计，40 周时 A1C 降低高达 2.07%（疗效）和 1.75%（治疗方案），安慰剂组约为 0%；根据疗效估计，体重减轻高达 9.5 公斤（15mg 剂量组为 -11%），而安慰剂组为 0.7 公斤（-1%）。

ADA 的讨论者指出，Reta 的减重效果优于其他肠促胰岛素类药物（基于交叉试验比较——见下方图表），并且尚未达到平台期。她还指出，这不仅仅是关于降糖和减重，Reta 似乎还具有更优的降压效果。她强调，Reta 4mg（低剂量）可能在减重诊所中是非常有用的工具。该试验还包括两个患者亚组，分别患有膝骨关节炎和阻塞性睡眠呼吸暂停，两组患者均因 Reta 治疗而获得了具有临床意义的益处。该试验未收集身体成分数据。最后，肥胖症试验的研究者指出，安慰剂组只有 75% 的患者完成了研究，其中 64% 完成了治疗（而 Reta 组为 89-91% 完成了研究，约 75-87% 完成了治疗），这凸显了进行安慰剂对照肥胖症试验的挑战，因为很难留住那些没有减重的患者。这一主题在我们参加的另一场 3 期肥胖症报告中也得到了呼应，该报告指出，退出该试验的安慰剂组患者中，约有 16% 独立地接受了 GLP-1 治疗。

Reta 安全性/耐受性：在 TRIUMPH-1 中，因不良事件导致的停药率在 Retatrutide 4mg、9mg 和 12mg 组分别为 4.1%、6.9% 和 11.3%，而安慰剂组为 4.9%。我们注意到，停药率总体上与注射用肥胖症疗法一致；作为背景，因不良事件导致的停药率低于 10% 是注射剂的典型情况。在 TRANSCEND-T2D-1 试验中，各剂量组的停药率也较低，分别为 2.2%、4.5% 和 5.1%，而安慰剂组为 0%，总体上与 Mounjaro SURPASS-1 试验中观察到的范围一致（3-7% vs 安慰剂组 3%）。

3/5

除预期的 Reta 胃肠道不良事件外，感觉迟钝（一种不愉快的异常触觉）和尿路感染也被特别提及，因为这些症状通常在其他肠促胰岛素类药物中未见。TRIUMPH-1 试验中，接受 retatrutide 4mg、9mg 和 12mg 治疗的患者感觉迟钝发生率分别为 5.1%、12.3% 和 12.5%，而安慰剂组为 0.9%；尿路感染发生率在 retatrutide 4mg、9mg 和 12mg 组分别为 7.5%、8.8% 和 8.4%，安慰剂组为 5.3%。不过 LLY 指出，大多数感觉迟钝和尿路感染事件为轻至中度，并在治疗期间缓解。据 LLY 称，减重手术也可能导致尿路感染。

虽然在 T2D 试验中 Reta 心律失常似乎存在轻微的不平衡，但在肥胖试验中并无不平衡（回顾一下，在 2 期试验中曾出现相关信号）。

• T2 心律失常和心脏传导障碍：Reta 4/9/12mg/安慰剂：4/2/1/0 • T1 心律失常和心脏传导障碍：Reta 4/9/12mg/安慰剂：1/4/5/5

T2D

数据的报告者指出，报告的心律失常并未随剂量增加而增多，且不严重，试验中也未发现心脏传导障碍。LLY 此前曾表示，他们预计未来几个月内 TRIUMPH-3 试验的数据将能完全排除心血管风险。

两项试验中均报告了少数死亡病例：

• T2 Reta 4/9/12mg/安慰剂：2/0/0/0 • T1 Reta 4/9/12mg/安慰剂：0/3/1/2

T2 试验中的两例死亡（Reta 4mg 组）包括一例心脏骤停，该患者用药一个月，但存在既有心脏风险因素和心脏病；第二例为有吸烟史的患者发生小细胞肺癌，发生在治疗结束后。T1 试验中的死亡病例未提供细节，但数量较少且总体平衡。在回答提问时，报告者指出，在较小/较短期的试验中观察死亡/MACE 事件时存在一定异质性，因此更适宜在大型结局试验中观察，例如正在进行的 TRIUMPH CVOT 试验（数据预计于 2029 年公布），这也得到了我们 KOL 的认同（见上文）。

图表 1：Reta 3 期项目总结



图表 2

来源：CT.gov, MS

LLY 预计将于 2026 年下半年提交 Reta 用于肥胖症的上市申请（2027 年上半年提交用于 T2D），并认为 Reta 符合 CNPV 计划设定的标准，但拒绝推测目前是否可以利用这一路径。

我们预测 Reta 将于 2027 年上市，风险调整后的 2030 年销售额为 46 亿美元（成功概率 70%）。

除了 ADA 会议，今年晚些时候还将公布更多 TRIUMPH 数据，包括针对伴有 T2D 的肥胖/超重患者（含 OSA 亚组）的 TRIUMPH-2 试验，以及针对伴有确诊心血管疾病的肥胖/超重患者的 TRIUMPH-3 试验。此外，根据 LLY 的 ADA 幻灯片，我们预计市场关注点将集中在预计于 2027 年公布的 TRIUMPH-5 试验（Reta vs. Tirzepatide）数据。

在活动中被问及 Foundayo 的上市情况时，公司表示他们对上市两个月以来所看到的情况感到兴奋，反馈良好且人群正在扩大。他们表示尚未启动所有推广手段。

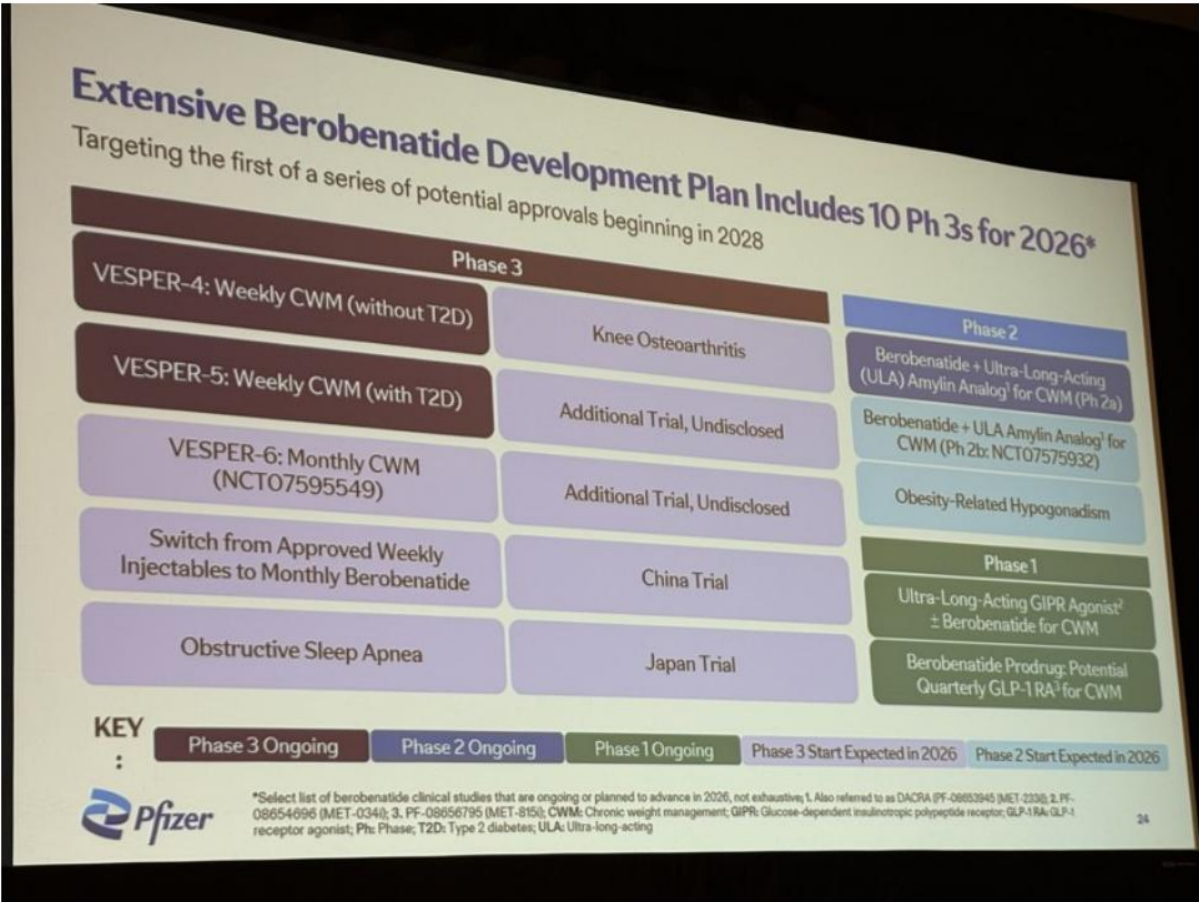
LLY 强调了正在开发的 Eloralintide（选择性作用于胰淀素受体 1>3），并回顾了之前的 2 期数据（见我们关于单药治疗数据的观点），特别指出 3mg 剂量可实现 12% 的体重减轻，且耐受性与安慰剂相似，无需剂量滴定。他们表示有 5 项 3 期试验正在进行中，并计划开展更多试验，预计这将成为 LLY

历史上最大的临床开发项目之一。他们对这款药物感到兴奋，并预计将于 2026 年下半年报告与 Tirzepatide（GLP-GIP）联用的 2 期数据。我们预测 Elora 将于 2028 年上市，风险调整后的 2035 年销售额为 57 亿美元（成功概率 60%）。

投资者对 LLY 潜在长效肠促胰岛素类药物（即每月给药一次）的计划兴趣日益浓厚。在 LLY 的活动中，管理层表示他们正在研究注射频率（我们假设这针对其现有药物）、新型超长效药物以及口服双靶点和三靶点激动剂

，因为他们不想在该领域留下任何未探索的角落。

图表 2：注射类肥胖药物跨试验疗效（体重减轻）比较



图表 3

来源：ADA 2026

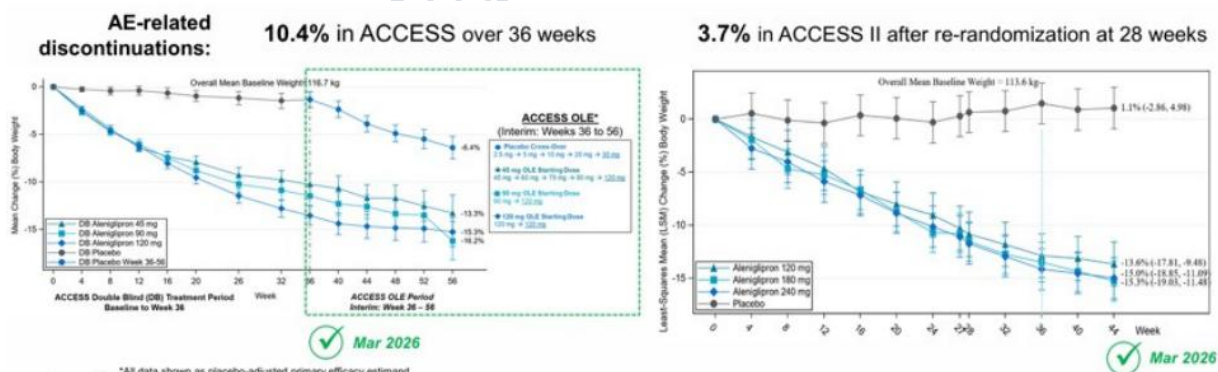
图表 3：注射类肥胖药物跨试验疗效（体重减轻阈值）比较



图表 4

来源：ADA 2026

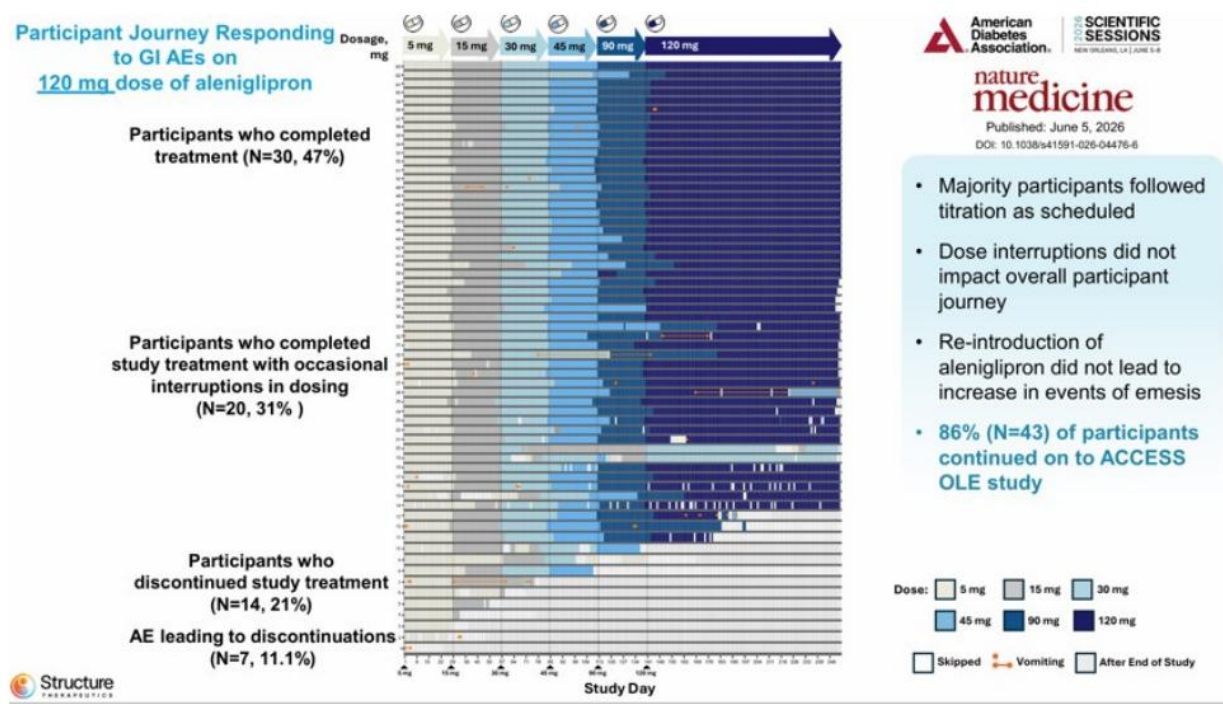
图表 4：注射类肥胖药物跨试验耐受性比较



图表 5

来源：ADA 2026

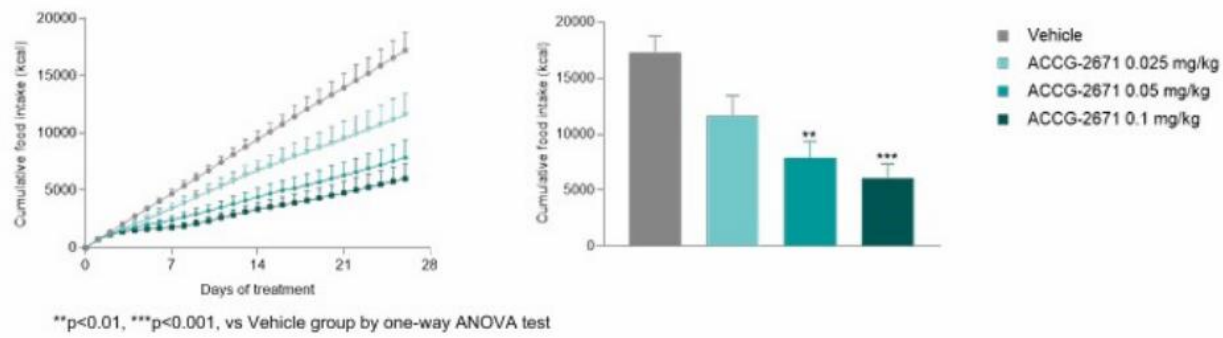
图表5：注射类T2D药物跨试验疗效（体重减轻）比较



图表 6

来源：ADA 2026

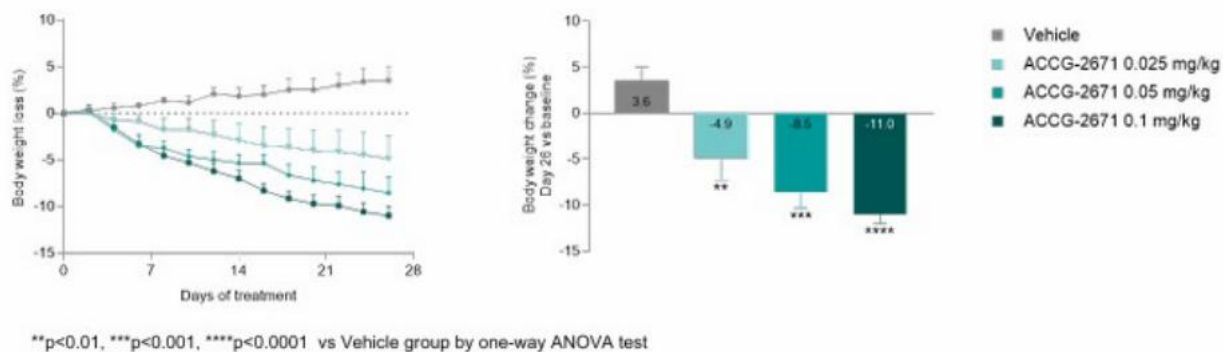
图表 6：注射类 T2D 药物跨试验疗效（HbA1c）比较



图表 7

来源：ADA 2026

图表 7：注射类 T2D 药物跨试验耐受性比较



图表 8

来源：ADA 2026

辉瑞

Berobenatide (Bero/PFE'3944/MET-097, 注射用 GLP-1) 的概况看起来具有竞争力, 与今年早些时候公布的 2 期顶线数据一致 (见此处)。我们认为完整的 2 期数据支持 Bero 进入 3 期试验, 是一个增量利好, 但我们预计这不会在当前阶段显著改变该股的整体叙事。我们认为, 目前 Bero 更像是 AMGN 的 Maritide (长效 GLP-GIP) 的潜在竞争对手, 而非 LLY 的产品线。

ADA 会议上的研究者展示了 Bero 三项 2 期试验的数据——针对伴有 T2D 肥胖患者的 VESPER-2 试验 (每周一次, 持续 28 周)、VESPER-1 开放标签扩展数据 (每周一次持续 28 周, 之后转为每两周一次或每月一次直至第 60 周), 以及 VESPER-3 肥胖试验 (每周滴定, 随后转为每月维持——第 28 周中期数据)。疗效报告采用治疗期间估计值 (试验产品)。

VESPER-2 (Bero 0.4-1.6mg 每周一次): 体重减轻 -2.5% 至 -10.2% (安慰剂 -0.7%), HbA1c 降低 -1.7% 至 -2.2% (安慰剂 -0.2%), 因不良事件停药率合计 7.5% (安慰剂 0%), 恶心发生率合计 24% (安慰剂 11.5%), 呕吐发生率合计 18% (安慰剂 4%), 腹泻发生率合计 26% (安慰剂 23%)。

VESPER-1 (Bero 0.4-1.2mg 每周一次): 前 28 周体重减轻 -6.4% 至 -12.5% (安慰剂 +1.7%)。开放标签扩展期 (Bero 2.4mg 每月一次、1.6mg 每两周一次、3.2mg 每月一次和 4.8mg 每月一次): 第 60 周体重减轻 -10.3% 至 -14.9%。开放标签扩展期因不良事件停药率为 0.6% (患者此前已接受 28 周每周一次给药)。

VESPER-3 (Bero 每周一次持续 12 周, 随后 Bero 3.2-4.8mg 每月一次直至第 64 周): 体重减轻 -9.8% 至 -12% (安慰剂 +0.2%)。因不良事件停药率合计 9.3% (安慰剂 0%), 恶心发生率合计 38% (安慰剂 15.1%), 呕吐发生率合计 23.3% (安慰剂 1.9%), 腹泻发生率合计 14.4% (安慰剂 5.7%)。

作为对比, 我们估计 LLY 的 Zepbound (每周给药) 在 SURMOUNT-1 3 期试验第 28 周时安慰剂校正后的体重减轻约为 10-14%, 而 AMGN 的 Maritide (每月给药) 在 2 期试验中实现了低两位数的百分比体重减轻 (安慰剂校正后)。

在 ADA 会议上, 关于 Bero 的讨论更多集中在耐受性而非疗效上。讨论者指出, 在她看来, Bero 的耐受性是她迄今为止在 GLP-1 药物中看到的最佳水平, 但她同时指出, 当患者从每周一次 (QW) 给药转为每月一次 (QM) 给药时, 胃肠道不良事件 (GI AEs) 出现激增 (例如, 呕吐率达到 24%), 她希望对此有更多了解 (我们注意到, PFE 已在 III 期研究中引入了更缓慢的剂量递增方案, 见下文)。另一位在场的知名意见领袖 (KOL) 表示, Bero 有效且数据看起来不错, 但他反驳了该药物具有最佳耐受性的观点, 并认为其与其他基于 GLP-1 的药物相似。小组中的一位 Bero 报告者回应称, 真相将在 III 期项目更大规模的数据中显现, 因此最好在此之前保留判断。

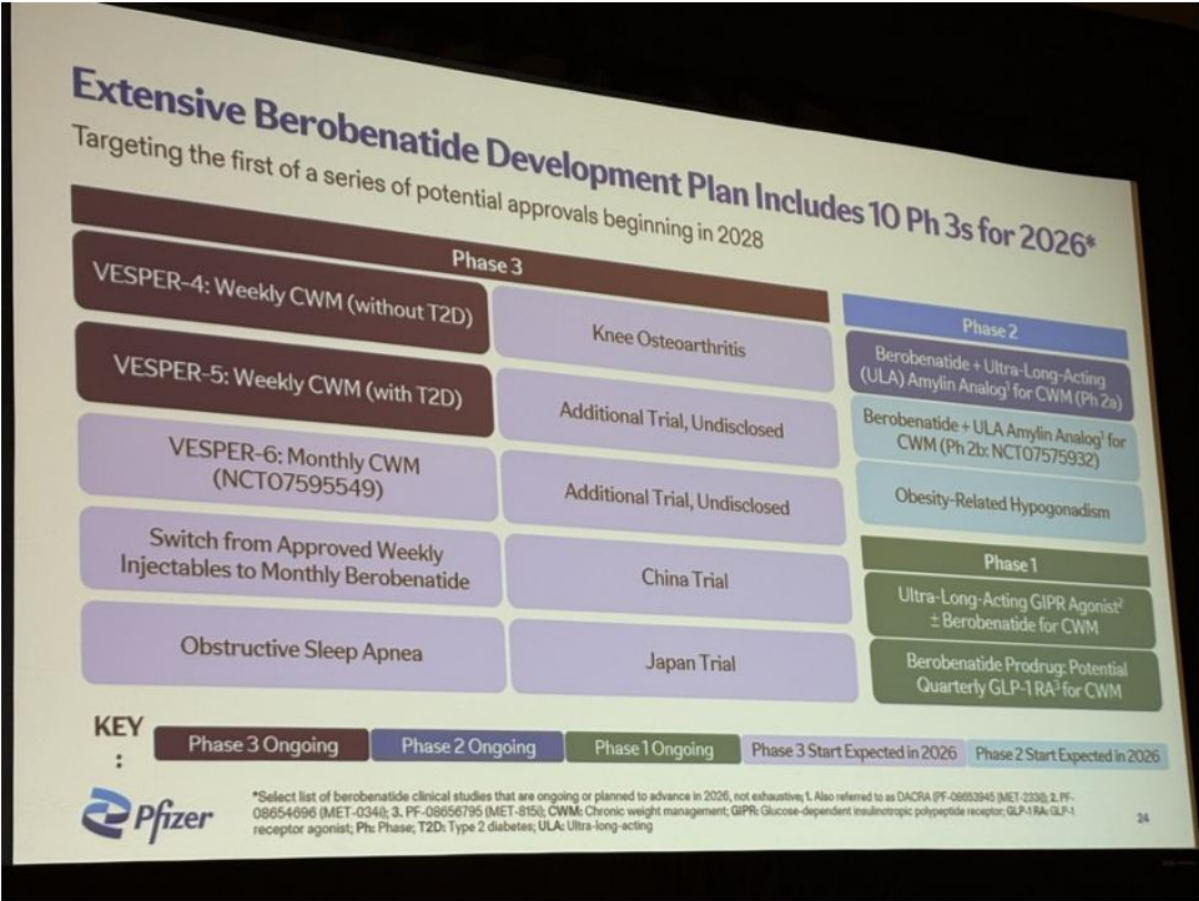
图表 8: VESPER-3 研究中的胃肠道不良事件 (GI AEs)

来源: 公司报告

虽然提供了 Bero 胃肠道不良事件 (GI AEs) 随时间发生的频率, 但 II 期研究并未捕获恶心/呕吐的平均持续时间数据 (这将在 III 期研究中收集)。这是一些医生对长效月制剂持续关注的问题, 因为担忧在于, 如果副作用持续时间比周制剂更长, 可能会对部分患者构成障碍。

PFE 正在开展 Bero 的广泛 III 期项目, 计划今年启动 10 项试验 (见下图)。前两项试验正在评估肥胖症 (VESPER-4) 和 2 型糖尿病 (T2D) (VESPER-5) 中的每周一次给药方案。他们指出, 这些 III 期试验采用简单的剂量递增方案, 仅需 1-3 步即可达到目标剂量, 而目前已获批药物通常需要约 5 步。

图表 9: Berobenatide 开发项目



图表 9

来源：公司报告

PFE已从Bero的II期项目（上文）中吸取了经验——他们调整了滴定方案，允许在出现耐受性问题时降低剂量，并且还在探索更高剂量的每月一次（QM）给药方案（9.6mg）。

图表10：Berobenatide III期项目



图表 10

来源：公司报告

首个探索Bero每月一次（QM）给药的III期试验（VESPER-6）现已开放并开始招募受试者。该试验包括两个队列——肥胖症队列和肥胖症伴2型糖尿病（T2D）队列。III期每月一次（QM）试验包含一个3.2mg的中间递增步骤（II期试验是从1.2mg直接递增至4.8mg）。

虽然PFE尚未披露Bero III期项目的全部范围，但将包括一项转换试验，不过他们并未承诺进行与Semaglutide或Tirzepatide（已获批的每周一次注射产品）的头对头（h2h）试验。

PFE的目标是在2028年推出Bero每周一次（QW）制剂（与我们的模型一致），并指出每月一次（QM）制剂的获批将紧随其后。对于Bero，我们模型预测其2030/2035年风险调整后销售额约为20亿美元/45亿美元（成功概率60%），约占2035年总收入的9%。

PFE表示，将在今年早些时候报告Bero与PF'3945（MET233；可注射胰淀素/DACRA）联合用药的II期试验数据。他们还将该联合用药推进至一项IIb期SOLIS-1试验（预计完成日期为2027年8月；n=872）。该公司还在开发一种Bero前药，这是一种超长效版本（半衰期未披露），目前处于I期阶段。

在商业方面，PFE预测注射类药物（而非口服药）仍将是肥胖症市场中最大的部分，并相信每月一次的药物将带来更多的新患者启动和转换。他们还指出，他们此前在初级保健市场属于后来者——以立普妥（Lipitor）、艾乐妥（Eliquis）和沛儿（Prevnam）为例——尽管进入市场较晚，但最终仍能占据领导地位。

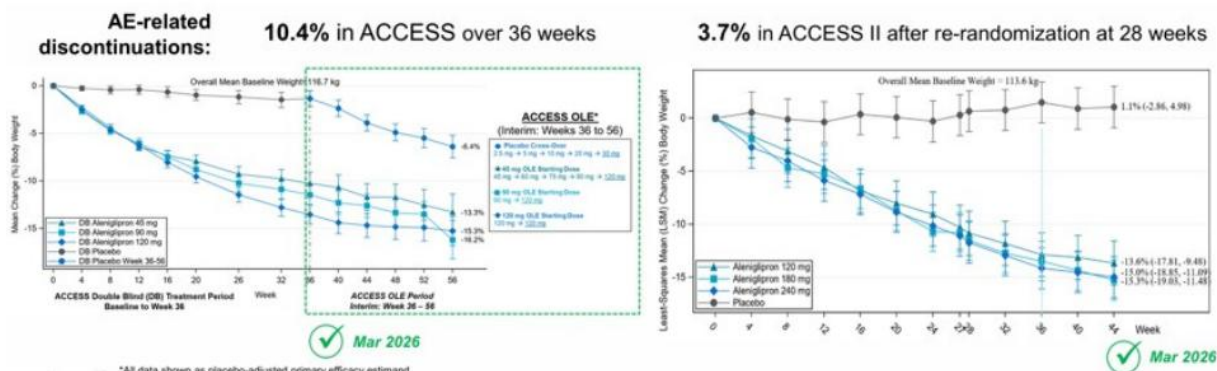
Structure Therapeutics

GPCR公布了完整的Aleniglipron（口服GLP-1）II期数据，包括不良事件（AEs）分期/剂量中断的新数据，以及ACC-2671（每日一次口服胰淀素/DACRA）在非人灵长类动物（NHPs）中的临床前联合用药数据。

ACCESS II期试验疗效：回顾一下，GPCR此前报告了ACCESS（45/90/120mg；链接）和ACCESS II（含180/240mg；链接）试验的顶线数据，其中Aleni显示出剂量依赖性的体重减轻。在ACCESS II研究中，根据疗效估计，Aleni在180mg剂量组实现了安慰剂校正后平均体重减轻16.3%（39磅；p<0.0001），在240mg剂量组实

现了16.0% (37磅; $p<0.0001$) (44周时)。另外, 在ACCESS开放标签扩展 (OLE) 研究中, Aleni从36周起持续减重, 至56周时120mg剂量组减重达16.2% (40.5磅); 详见下方图表11摘要。两项研究均未显示体重减轻平台期, 我们认为这令人鼓舞。其疗效与LLY的Orforglipron (口服GLP-1) 具有竞争力, 但需注意交叉试验比较的典型局限性 (图表17)。

图表11: Aleni ACCESS和ACCESS II疗效数据摘要

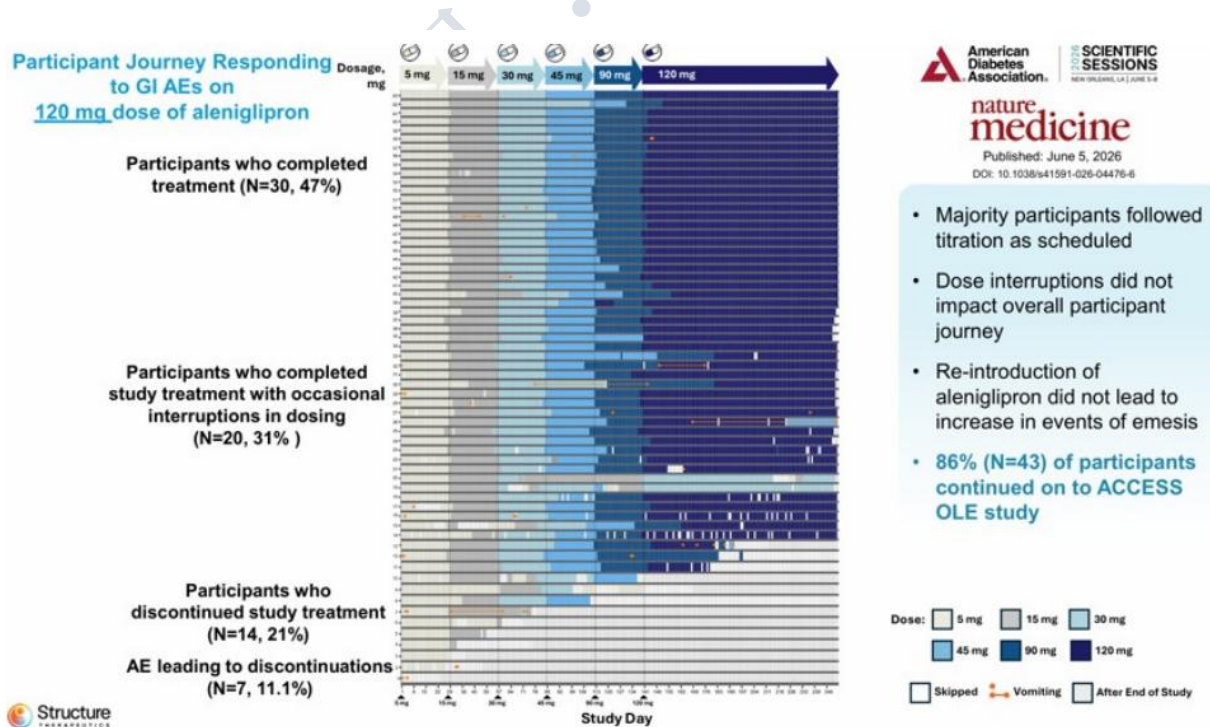


图表 11

来源: 公司报告, ADA 2026

Aleni安全性/耐受性: Aleni的安全性和耐受性与GLP-1类药物一致, 如下方图表12所述的剂量滴定方案所示, 较高剂量下不良事件 (AEs) 未见明显增加。Aleni各治疗组中, 因治疗相关不良事件导致的停药率为10.4%, 无药物性肝损伤事件发生。剂量中断 (下方面板中以白色单元格标示) 后, 重新开始Aleni治疗时通常不会出现复发性呕吐。根据报告者的说法, 这些数据表明患者可以在剂量中断后成功重新开始Aleni治疗或继续递增剂量, 这相对于注射类药物而言, 一直是口服GLP-1药物的关注焦点。

图表12: Aleni剂量递增/中断



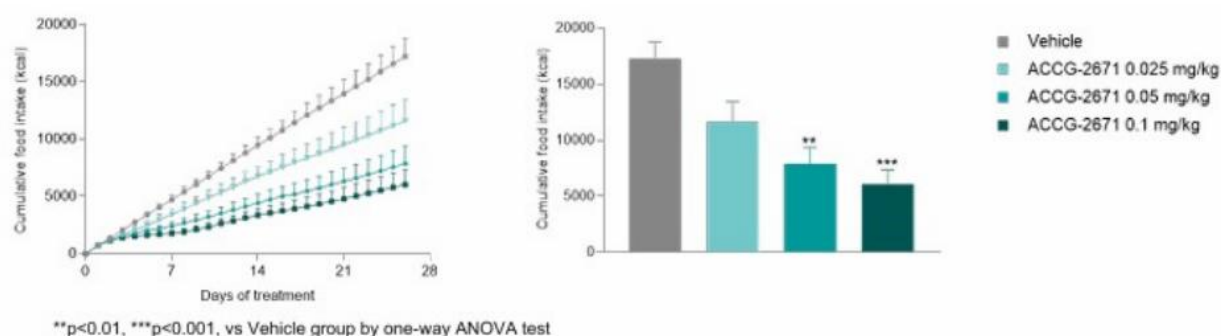
图表 12

来源: 公司报告, ADA 2026

Aleni III期项目按计划于2026年第三季度启动: 该公司此前已收到FDA积极的II期结束 (EOP2) 反馈, 并计划于2026年第三季度启动其III期肥胖症试验。该项目将使用2.5mg的起始剂量 (与身体成分/开放标签扩展 (OLE) 试验一致, 而ACCESS/ACCESS

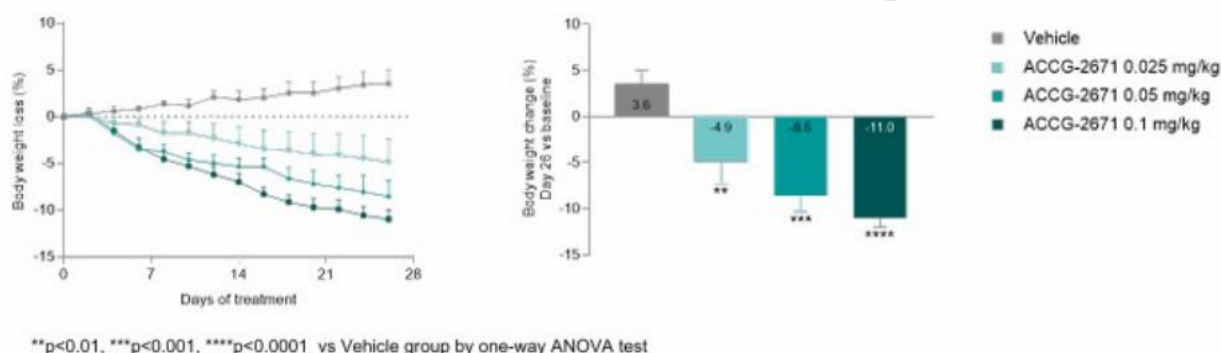
II试验使用5mg)，原因是其耐受性改善且能立即带来减重获益，最高剂量仍未确定。

图表13：ACCG-2671单药治疗非人灵长类动物（NHP）数据 累积食物摄入量：ACCG-2671单药治疗



图表 13

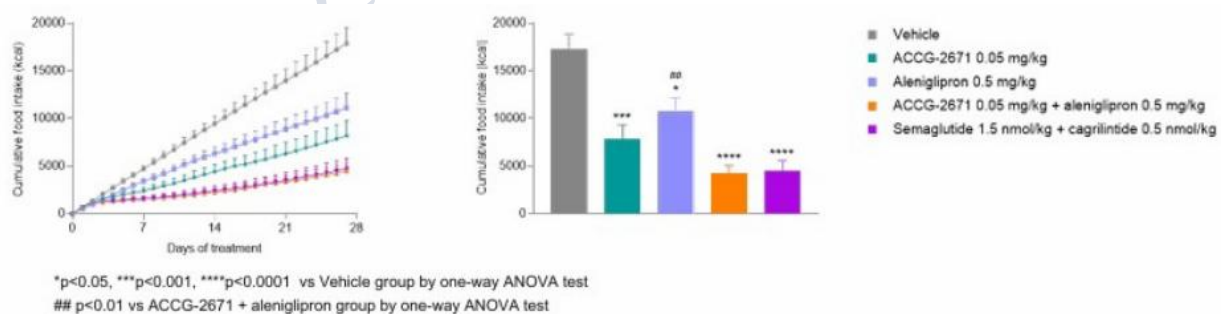
慢性体重减轻：ACCG-2671单药治疗



图表 14

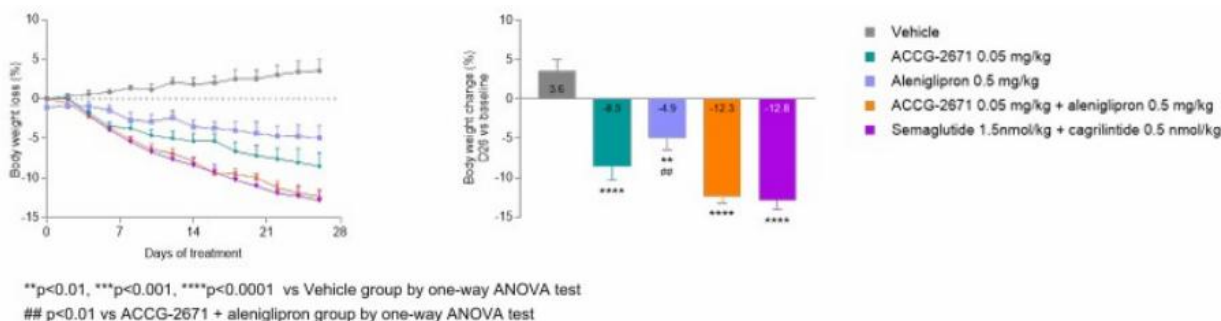
来源：Fang等人，ADA 2026

图表14：ACCG-2671+Aleni联合用药非人灵长类动物（NHP）数据 累积食物摄入量：ACCG-2671 + aleniglipron联合给药治疗



图表 15

慢性体重减轻：ACCG-2671 + aleniglipron联合给药治疗



图表 16

来源：Fang等人，ADA 2026

交叉试验比较

图表15：肥胖症中可注射GLP-1的交叉试验比较

来源：公司数据，MS；*Reta试验的所有II期疗效数据均来自疗效估计

图表16：2型糖尿病（T2D）中可注射GLP-1的交叉试验比较

来源：公司数据，MS

图表17：肥胖症中口服GLP-1的交叉试验比较

‡ 疗效估计数据 * 数据可能来自疗效估计

来源：公司数据，MS

估值方法与风险

Structure Therapeutics Inc (GPCR.O)

我们的126美元目标价包含2040年预计约34.6亿美元的风险调整后收入（未调整收入为63亿美元）。我们通过贴现现金流（DCF）分析得出目标价，贴现率为12.5%，终值增长率为0%。

上行风险

GSBR-1290肥胖症数据优于预期，和/或开发时间表加快。

下行风险

GSBR-1290肥胖症数据令人失望，和/或开发时间表延迟。

礼来公司 (LLY.N)

我们12个月目标价为1,344美元，基于27倍市盈率，对应我们2027年第二季度至2028年第一季度每股收益预估49.76美元。该倍数与礼来10年平均水平（28倍）及行业水平（约15倍）一致，但考虑到公司的增长前景和管线选择权，我们认为这一估值合理。

上行风险

■ Founday/orfor商业化上市表现优于预期 ■ Elora/Reta在临床试验/商业化中表现优于预期 ■

礼来在政府肥胖症渠道的市场份额增长快于我们的预期

下行风险

■ Founday/orfor获批延迟或商业化上市表现不佳 ■ Eloralintide和Retatrutide在上市前终止开发 ■

竞争对手在糖尿病-肥胖症管线药物的数据

辉瑞公司 (PFE.N)

上行风险

■ COVID-19检测、疫苗和治疗成为常规业务 ■ 辉瑞/ BioNTech成功开发COVID-19+流感联合疫苗 ■

辉瑞面临专利到期的产品下降速度慢于预期

下行风险

■ COVID-19大流行已成为过去 ■ 辉瑞/ BioNTech的COVID+流感联合疫苗临床试验未获成功 ■
辉瑞现有产品线面临商业挑战和/或管线受挫

公众号：KC桌面